

1 薬剤の分類マップ

B細胞性リンパ腫 CD20などB細胞を標的	抗CD20抗体 リツキシマブ オビヌツズマブ 多剤併用(R-CHOP等) シクロホスファミド ドキソルビシン ピンクリスチン ブレドニゾロン ADC ポラツズマブ ベドチン
慢性骨髄性白血病 BCR-ABLを阻害	第1世代 イマチニブ 第2世代 ダサチニブ ニロチニブ ボスチニブ 第3世代・新規機序 ポナチニブ アシミニブ
多発性骨髄腫 骨髄腫細胞の生存を阻害	プロテアソーム阻害薬 ボルテゾミブ カルフィルゾミブ イクサゾミブ 免疫調節薬(IMiDs) レナリドミド ポマリドミド サリドマイド 抗体薬 ダラツムマブ イサツキシマブ
細胞療法・二重特異性抗体 T細胞でがんを攻撃	CAR-T細胞療法 CD19標的(リンパ腫) BCMA標的(骨髄腫) 二重特異性抗体 エブコリタマブ エルラナタマブ テクリスタマブ

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(代表的な3疾患)

対象	1次治療 薬局の出番	2次治療	3次治療以降
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	● R-CHOP、またはPola-R-CHP	● 救済化学療法→自家移植 ● CAR-T細胞療法	● CAR-T ● 二重特異性抗体 ● ポラツズマブ+BR 等
慢性骨髄性白血病慢性期	● イマチニブ ● ダサチニブ ● ニロチニブ ● ボスチニブ	● 他のTKIへ変更(耐性変異・副作用に応じて選択)	● ポナチニブ(T315I変異) ● アシミニブ
多発性骨髄腫移植非適応	● ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン(DRd) 等	● カルフィルゾミブ・ポマリドミド・抗体薬の組み合わせ	● 二重特異性抗体 ● CAR-T 等

● 細胞障害性抗がん薬中心 ● 分子標的薬(注射)を含む ● 経口薬を含む ● 免疫チェックポイント阻害薬

移植適応の多発性骨髄腫は、導入療法(ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン±ダラツムマブ)→自家造血幹細胞移植→レナリドミド維持療法が基本。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	半年～
● インフュージョンリアクション	● 初回投与中～24時間					
● 腫瘍崩壊症候群	● 治療開始～数日					
● CRS・ICANS(CAR-T等)	● 投与後数日～2週					
● 好中球減少(nadir)		● 7～14日目				
● 便秘・末梢神経障害			● 数週～累積で増強			
● 帯状疱疹(ボルテゾミブ)			● 治療期間中(予防投与を継続)			
● 胸水(ダサチニブ)				● 数か月～年単位でも		
● B型肝炎再活性化					● 治療中～終了後1年以上	

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 病型ごとに治療体系が異なる:リンパ腫=抗CD20抗体、CML=BCR-ABL阻害薬、骨髄腫=多剤併用
2. B型肝炎再活性化・催奇形性管理・CRS/ICANSなど、固形がんとは異なる重点管理項目がある
3. 年単位の経口薬と予防投与の継続確認は、保険薬局の薬剤師が担う重要な役割